



INFORMACIÓN A PACIENTES

DETECCIÓN PRECOZ DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA CON RETINOGRAFÍA

La diabetes produce lesiones en la membrana interna del ojo, llamada retina (retinopatía diabética) y es la causa más frecuente de ceguera entre la población de los países desarrollados. Si usted tiene diabetes no significa que su vista se afectará sin más remedio, pero tiene más riesgo que el resto de la población. Si su diabetes se controla bien, probablemente será más difícil tener problemas oculares, o ellos serán menos serios. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico precoz.

Actualmente se hacen fotografías (retinografías) de la retina que son examinadas por el médico de familia y también por el oftalmólogo. De esta manera, se decide si el paciente tiene que ir al especialista para un estudio más completo o para tratamiento.

Para hacer esta prueba es mejor dilatar (aumentar de diámetro) la pupila o "niña" del ojo, para ello es necesario ponerle en sus ojos unas gotas de un colirio (tropicamida). **Todas las personas después verán más borroso y estarán deslumbradas durante un tiempo (3 a 6 horas) por lo que se aconseja no conducir**, ni realizar trabajos que precisen buena visión (lectura, costura, manejo herramientas o maquinarias peligrosas, etc). **Le producirá cierto malestar la luz solar intensa, que se puede disminuir con el uso de gafas de sol.** Después de ese tiempo se vuelve a la normalidad.

A veces puede producirse como complicación: Dolor de clavo (glaucoma agudo): aparece horas más tarde de poner las gotas. Si usted tiene visión muy borrosa con dolor fuerte en el ojo, a veces dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Esta complicación tiene tratamiento por lo que debe usted acudir al Servicio de Urgencias más cercano si nota alguno de estos síntomas.

Usted **no debe hacerse esta prueba** si tiene **antecedentes de dolor de clavo** o si está usando un **colirio de pilocarpina** (colirios con el tapón verde). Del mismo modo, **si ya está diagnosticado de daño en la retina** (retinopatía) o usted está en **revisión por el oftalmólogo** por cualquier otro motivo, es habitual que ellos le revisen la retina mediante la exploración del fondo de ojo, por lo que tampoco sería necesario realizarse esta prueba.

INDICACIÓN DE RETINOGRAFÍA

NOMBRE: _____ **NUHSA:** _____

DIABETES TIPO: ☐ TIPO 1 ☐ TIPO 2 **AÑOS DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES:** _____

FECHA ÚLTIMA RETINOGRAFÍA ☐ _____ ☐ PRIMERA VEZ

- ☐ **Revisión anual:** Pacientes diagnosticados de RD leve (microaneurismas).
- ☐ **Revisión a los dos años:** Pacientes con retinografía anterior normal y otros factores de riesgo (HTA, nefropatía, HBA1c >8, más de 10 años de evolución)
- ☐ **Revisión a los tres años:** Pacientes con retinografía anterior normal y sin factores de riesgo.